



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سهره سعد محمد فرغلى

العنوان : 8 شارع عبد الحكيم
يوسف

الحي / المدينة : ساقية مكي

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

رقم البطاقة : 28104052600265 رقم التليفون : 01063683917

العمر (تاريخ الميلاد) : 05-04-1981 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا أتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك الإخصائي الاجتماعي التوقيع: (-----) المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة. تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سهره سعد محمد فرغل National ID: 28104052600265	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢١/١١

٢٨١٠٤٠٥٢١٠٠٢٦٥

رؤية منزل

مستعمدة



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/١١/١٣



د. يوسف
د. هادي
د. نعيم
د. علاء



د. محمد فرحان
رئاسة تحرير المراجعة

سيرة

سيد محمد فرحان

٨ ش. عبد الحكيم يوسف سلقه مكي
الجزء - الجزء

٢٨١٠٤٠٥٢١٠٠٢٦٥

JD2881791

Patient Name : سهره سعد محمد فرغلي
Patient Info. : Female 45Y
Department : Out Patient
Profile NO. : 3148-2023 /28104052600265

Patient Id : 1104
VisitId : 1101
Collection Date : 13/11/2025 12:22:15
Reporting Date : 13/11/2025 14:29:47

Clinical Chemistry Report

Test	Result	Unit	Reference Range
<u>Kidney Function</u>			
Creatinine	: 0.59	mg/dL	0.5 - 1.2
Calcium Ionized (Ca++)	: 1.11	mmol/L	N. 1.1 - 1.4

Signature
Dr. Asmaa Hamed ElQenawy

nt Name :
nt No. : 28104052600265
No. : 2399/23
: Female
: 42 Y

Request No. : 13003827
Request Date : 29/07/2023
Verification Date : 20/08/2023
Financial Category :
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

relng Doc :

Pathology Report

al Data: Right breast mass.

o of Specimen: Tru-cut blospy, collected at 27/7/2023, 3:15 pm.

s Examination:

r grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
tions prepared from paraffin block for Immune-staining using Bench Mark ULTRA
m for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-

scope Examination:

ological type: Invasive duct carcinoma.
do (differentiation): nuclear pleomorphism: mitosis: (2+2+1) Grade II
tal carcinoma in situ: No.
neural invasion: No.
lo invasion: No.

(Positive control showed appropriate reactivity):
Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8).
Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8).
:: Faint incomplete membrano reaction in > 10% of tumor cells (score 1+)
: 25% nuclear reaction of tumor cells.

osis:

breast mass, Tru-cut blospy:
vo duct carcinoma, Grade II.

Positive (score 8/8).

Positive (score 8/8).

: (score 1+).

Verified by :

DR. Menna Nabil

g Date : 20/08/2023 12:03:14

Page 1 of 1

Printing by : marwa mohamed youss

Name :
No. : 28104052600265
: 2399/23
: Female
: 42 Y

Request No. : 13003827
Request Date : 20/07/2023
Verification Date : 20/08/2023
Financial Category :
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

ng Doc :

Pathology Report

Positive in 25% of tumor cells.

ig system: "ER, PR"

CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

g system: "Her2"

co: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible in < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: in circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential no staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Manal ElMahdy.
Dr. Rana Fathy.

Verified by :
DR. Menna Nabil

ate : 20/08/2023 12:03:11

Page 1 of 1

Printing By : marwa mohamed youss

Patient Name: Sahra Saad Mohamed Farghali	Date : 27/08/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 3148/2023	Pat ID: 41339

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST:

Findings:

- > Right LOQ breast mass lesion measuring 3.5x3cm with enlarged right axillary lymph nodes, the largest at right side measuring 1.7x2cm.
- > Clear both lung fields. No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitory lesions.
- > No hilar or mediastinal lymph nodes.
- > No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- > No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- > Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- > Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- e No CT evidence of pulmonary metastases or pneumonia.

Dr. Amir Farouk M.D.

1. Name:
 2. Date of Birth:
 3. Address:

4. Medical Number

5. Date of Birth

6. Date of Birth



1. Name:
 2. Date of Birth:
 3. Address:
 4. Medical Number:
 5. Date of Birth:
 6. Date of Birth:

7. Date of Birth:
 8. Date of Birth:

1. Name: 2. Date of Birth: 3. Address:		4. Medical Number: 5. Date of Birth: 6. Date of Birth:	
7. Date of Birth: 8. Date of Birth:	9. Date of Birth: 10. Date of Birth:	11. Date of Birth: 12. Date of Birth:	13. Date of Birth: 14. Date of Birth:

1. Name:
 2. Date of Birth:
 3. Address:
 4. Medical Number:
 5. Date of Birth:
 6. Date of Birth:

7. Date of Birth: 8. Date of Birth:

9. Date of Birth: 10. Date of Birth:

1. Name: 2. Date of Birth: 3. Address:	4. Medical Number: 5. Date of Birth: 6. Date of Birth:
7. Date of Birth: 8. Date of Birth:	9. Date of Birth: 10. Date of Birth:

Name: Mrs. Sahra Saad Mohammed

Date: 2026-09-21

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography

revealed:

Clinical summary: Status post right CBS & ALAND, followed by radio therapy, routine follow up study.

Findings:

Right breast.

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- UOQ, architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry, or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated UOQ area of parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid, cystic lesions or fluid collections.
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- Clear right axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Left breast.

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin, nipple/areola.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion: -

Right breast (BIRADS 2): Post-Therapeutic sequelae.

Left breast (BIRADS 1): Normal study

Recommendation: -

For annual follow up.

Best Regards,
DR. Amal Hegazi, M.Sc.

BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology used for breast assessment combined with recommendations:

Category & recommendations

	<u>Suspected Cancer Risk</u>
BIRADS 0: Non-informative study.	
BIRADS 1: Normal study, routine screening	0 %
BIRADS 2: Benign findings, routine screening	0 %
BIRADS 3: Probably benign, for close follow up.	2 %
BIRADS 4: Probably malignant, for biopsy.	50 %
A: mild suspicion.	
B: moderate suspicion.	
C: high suspicion.	
BIRADS 5: Malignant, for biopsy.	98-100%
BIRADS 6: Pathologically proven malignant	